



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : ناديه فهمى واصف عبدالله
المحافظة : القاهرة الحي / المدينة : الساحل
رقم البطاقة : 25012310101969 رقم التليفون : 01223531516
العنوان : 00
العمر (تاريخ الميلاد) : 31-12-1950 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 22-09-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام
التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير المستشفى.
تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
قسم : -----
جهة العلاج : -----
نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: نادية فهمي واصف عبدالله National ID: 25012310101969	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



الجمهورية العربية السورية
مكتب التسجيل
بيروت
فهمي واصف عبدالله
١٠. محمد عثمان غلال. كمال حسين كاسل
السجل - القاهرة



٢٥٠١٩٣١٠١٠١٩٦٩

KR7861207

١٤٠٠٦٦١٥٥٩

٢٤ ٩٨
٩٠١٩



٢٠٢٤/٠٨ ٢٥٠١٢٣١٠١٠١٩٢٤
ربة منزل

متروجة
التي
مسيحية
طريف غطاس بطرس
البطاقة سارية حتى ٢٠٣١/٠٨/١١



Pathology Report

Name: نادية فهدى وصيف

Age: 68 years.

Clinical data: Left breast mass.

Specimen type: Tru cut biopsy.

Date: 22 /9/2019

Lab. Number: 834

Hospital Number: 3298/2019

Gross Description:

Four grayish white tissue cores; longest 1.5cm. Totally submitted.

Microscopic Examination:

Sections examined revealed cores of fibrotic stroma. Infiltrated by files, loose clusters of moderately and large sized epithelial cells supported by fibrocollagenous stroma, mildly infiltrated by small lymphocytes. No evidence of any solid component in the received material.

Diagnosis:

Left breast mass. Tru cut biopsy of the mass. Ductal carcinoma in situ.

Prof. Dr. Aml Harcedy

Prof. Dr. Essam Ayad



Pathology Report

Name: نادية فهمي راضف

Age: 68 years.

Clinical data: Left breast mass.

Specimen type: Left quadrantectomy and axillary clearance

Date: 17/10/2019

Lab. Number: 1037

Hospital Number: 3298/2019

Gross Description:

A sector of breast tissue; 10x4x7.5 cm, with partial skin covering, 8x2.5 cm and with attached axilla; 12x9x3.5 cm, all received enblock.

Serial cuts revealed an ill-defined firm greyish white mass, 2.5x2 cm, located; 2.5 cm deep to skin and located (6.5, 1.5, 1.2, 1.3 & 1.2) cm from (lateral, medial, superior, inferior & deep) margins respectively.

Axillary dissection revealed 20 nodules, 1.5x1.5 cm, all examined.

Microscopic Examination:

Histopathological examination of sections prepared from each breast tissue showing infiltrating tumor, formed of moderately pleomorphic cells, showing moderate tubular differentiation and focal areas of necrosis, surrounded by moderate desmoplasia.

No perineural invasion.

No lymphovascular tumor emboli.

DCIS is 10%, showing cribriform and comedo type.

Surgical margins are free.

No lymph node metastasis, LN 0/20.

Diagnosis:

Left quadrantectomy and axillary clearance.

- Invasive duct carcinoma GII.
- DCIS 10% (cribriform and comedo type).
- No lymphovascular emboli.
- No perineural invasion.
- Free surgical margins.
- LN 0/12.
- Tumor stage pT2 pN0.

Prof. Dr. Lubna Omar

Dr. Liza Nessim

Dr. Dr. Essam Ayad

خطابات اورام

Patient Name : نادية قهسي واصف

sex : female

Age: 69

Hosp.Word : ct

Patient status : outpatient

Path.No. : 0000

IHC . No : 12089

Referring Doctor: شرميل السلام

Date : 25-11-2019

Provisional Diagnosis: breast cancer, Request for ER & PR

Immunohistochemistry Report

CLINICAL/ RADIOLOGIC DATA

breast cancer.

GROSS PATHOLOGY

Received 2 paraffin block.

IMMUNOHISTOCHEMISTRY

Immunostaining effectuated on 5 µm thick paraffin sections. The heat induced epitope retrieval using microwave, the ChemMate DAKO Envision, DAKO autostainer and the following antibodies:

- Estrogen receptors: strong nuclear staining of more than 95% of the neoplastic cells (PS5 IS3).
- Progesterone receptors: strong nuclear staining of more than 95% of the neoplastic cells (PS2 IS3).

CONCLUSION

- Estrogen receptors, positive, score 8/8
- Progesterone receptors, positive, score 5/5

Enclosed :

Slides :

Blocs :

مركز الأورام - مستشفى جامعة القاهرة

أ.د. / د. هويدا محمد عبد الحليم

Director Immunohistochemical Lab

Prof. Hoda M. El-Sherpieny

25-11-2019



Abdominal fatty liver

Date: 27 August 2025

ABDOMINO-PELVIC ULTRASOUND EXAMINATION REVEALED:

Liver: -

- enlarged in size about 18.5 cm at the right MCL, smooth outline, bright echopattern
- No intra hepatic biliary radicle dilatation
- Portal vein is not dilated and patent

Gall Bladder: -

- Average size, and wall thickness, no stone seen inside
- CBD is not dilated

Spleen: -

- Average size (about 12 cm), displaying homogenous echopattern

Kidneys: -

- Are of normal size, site, well differentiated & with no gross lesions
- Both kidneys: kidneys, no solid lesion, two simple cortical cysts seen, one in each side - the right is smaller (8 mm) in diameter seen at the lower zone, the left is (20 mm) in diameter, seen in upper zone
- Para-aortic and pancreatic area: no gross lesion
- No adenitis

Urinary Bladder: -

- Average capacity with no stones, masses or other lesions seen

Uterus: removed.

Both adnexa: - no abnormalities could be detected

Opinion:

- Bright enlarged liver likely fatty.
- Bilateral renal simple cyst.

Best regards
Dr. Doha Ahmed
MSc, FEBR

Patient name: Nadia Fahmy Wasy

Date: 1/11/2020

Combined bilateral breast mammography and complementary ultrasound

Indication:

Patient is 69 years old and is seen for follow up after CBS and RTH

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral 3D MLO DBT (Digital Breast tomosynthesis)
- Bilateral breast ultrasound

Report:

Left breast:

- Diffuse edema pattern with skin thickening
- Left LQO scarring with mild distortion
- Complementary ultrasound showed left diffuse edema pattern and skin thickening reaching 8.8mm
- No suspicious lesions
- No pathological axillary lymph nodes

Right breast:

- Scattered fibroglandular density visible
- Scattered benign looking calcifications
- No suspicious micro calcifications or architectural distortion detected
- Complementary ultrasound no cystic or solid mass detected
- Normal skin thickness, and nipple areola complex with average caliber of the retro areolar central ducts
- Nonspecific axillary LN

Free supra and infra clavicular regions

Opinion:

- Left breast S/P CBS & RTH showing expected post therapeutic changes (BIRADS 2)
 - Right side benign calcifications (BIRADS 2).
- Yours truly